



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

ISABELLA VAZ DA COSTA ALECRIM

IMPLANTE IMEDIATO PÓS EXODONTIA NA REGIÃO ANTERIOR DA MAXILA

ISABELLA VAZ DA COSTA ALECRIM

IMPLANTE IMEDIATO PÓS EXODONTIA NA REGIÃO ANTERIOR DA MAXILA

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientador: Prof. Jorge Antonio Mansur de Miranda, Leonardo Silveira Damasceno e Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

ISABELLA VAZ DA COSTA ALECRIM

IMPLANTE IMEDIATO PÓS EXODONTIA NA REGIÃO ANTERIOR DA MAXILA

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

O implante imediato é uma abordagem moderna dentro da implantodontia que permite a instalação do implante logo após a extração dentária, trazendo benefícios como a preservação dos tecidos, o encurtamento do tempo de tratamento e a recuperação da estética do sorriso. Essa técnica mostra-se especialmente vantajosa quando aplicada na região anterior da maxila, onde há alta exigência estética e grande impacto na autoestima do paciente. O sucesso do procedimento, no entanto, depende diretamente do correto planejamento cirúrgico e protético, bem como das condições anatômicas e clínicas do paciente. Diante disso, este trabalho teve como objetivo estudar a técnica do implante imediato na região anterior da maxila, destacando suas indicações, benefícios, limitações e exigências clínicas. A análise demonstrou que, quando bem indicada e executada, a técnica do implante imediato proporciona resultados previsíveis e satisfatórios, tanto do ponto de vista funcional quanto estético. Entretanto, ressalta-se que nem todos os pacientes são elegíveis para o procedimento, sendo essencial a avaliação criteriosa por parte do cirurgião-dentista para garantir a previsibilidade do tratamento e a harmonia do sorriso restaurado.

Palavras-chave: Implante Imediato. Maxila Anterior. Estética. Reabilitação Dentária. Implante Dentário.

ABSTRACT

Immediate implant placement is a modern approach within implant dentistry that allows the installation of the dental implant immediately after tooth extraction, offering benefits such as tissue preservation, shorter treatment time, and restoration of the smile's aesthetics. This technique is particularly advantageous in the anterior maxillary region, where aesthetic demands are high and tooth loss significantly affects the patient's self-esteem. However, the success of this procedure depends directly on proper surgical and prosthetic planning, as well as the patient's anatomical and clinical conditions. Therefore, this study aimed to analyze the technique of immediate implantation in the anterior maxilla, highlighting its indications, benefits, limitations, and clinical requirements. The methodology was based on a literature review using scientific articles and reference works obtained from platforms such as Scielo, PubMed, and other reliable academic databases, prioritizing publications from the last ten years. The analysis demonstrated that, when well indicated and performed, immediate implant placement offers predictable and satisfactory results in both functional and aesthetic terms. Nevertheless, it is emphasized that not all patients are candidates for this technique, and a thorough evaluation by the dental surgeon is essential to ensure treatment predictability and a harmonious restored smile.

Keyword: Immediate Implant. Anterior Maxilla. Aesthetics. Dental Rehabilitation. Dental Implant.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 DESENVOLVIMENTO	9
2.1 OSSEOINTEGRAÇÃO.....	9
2.2 IMPLANTE IMEDIATO.....	11
2.3 DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO: AVERIGUAÇÃO DE PRÉ-REQUISITOS PARA QUE HAJA A POSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE IMPLANTES IMEDIATOS	14
3 CONCLUSÃO.....	17
REFERÊNCIAS.....	18

1 INTRODUÇÃO

O sorriso encontra-se diretamente ligado as condições de beleza, pois mediante padrões impostos pela sociedade ele deve seguir um modelo que seja harmonioso com o portador, para que ele (o portador) tenha êxito nas suas expressões de alegria, sensualidade, afeto e outras. Um belo sorriso tem a capacidade de produzir e transmitir sensações, por isso, ele promove bem-estar, autoestima e saúde para o indivíduo, ao mesmo tempo que emite uma expressão de empatia social (Magro et al., 2015).

Quando se analisa o sorriso anatomicamente, é notado que ele é o resultado da exposição dos dentes e da gengiva durante a contração dos grupos musculares dos terços médio e inferior da face (Souza et al., 2021). Do ponto de vista leigo social, um belo sorriso é determinado pela composição completa da arcada dentária seguida de sua oclusão, contudo, o primeiro fator sobressai a qualquer outro que possa ser evidenciado, quando a expectativa encontra-se elencada a ação de se ter um belo sorriso (Martins et al., 2020).

Como o sorriso é considerado uma peça fundamental da beleza, já que atrela-se as condições de estética da face, constantes buscas e pesquisas (que têm como finalidade melhorá-lo tanto em suas questões estéticas como funcionais) podem ser observadas na atualidade. Dentre tais buscas, faz-se notório salientar que, aqueles recursos e materiais que entregam ao paciente um resultado rápido, efetivo, sem grandes invasões e consequentemente com baixo risco de reações adversas, têm sido os mais benquistos. Em virtude disso, a odontologia com suas especialidades mantém-se na constante busca para a promoção, recuperação e manutenção do belo sorriso dos seus pacientes (Souza et al., 2021).

Como as demais áreas da odontologia, a implantodontia sofreu avanços significativos e bastante promissores, quando o assunto tem como temática a recuperação funcional e estética do sorriso. Sendo assim, é possível determinar que a reabilitação oral para aqueles pacientes que sofriam com a falta de dente(s) passou por uma grande evolução após a descoberta da osseointegração (Bezerra, 2022).

Os implantes osseointegrados no tratamento de pacientes desdentados promulgam a recuperação funcional e estética perdida, pois são restabelecidas a

mastigação, a fonação e a autoestima (Ribeiro, 2021). Destaca-se que discussões acerca de instalação de implantes para substituição dos dentes perdidos têm sido debatidas constantemente desde a década de 1960, iniciando-se pelo professor Branemark, que desenvolveu um protocolo que possibilitava a utilização de implantes osteointegrados para tratamento de pacientes edêntulos, ao qual foi possível constatar o sucesso desde o princípio (Coelho, 2019).

A osseointegração na odontologia é uma possibilidade de terapia que possibilita uma melhor e maior previsibilidade quanto aos resultados que serão obtidos, ou seja, ela favorece o alcance do sucesso na implantodontia. O professor Branemark, com o seu protocolo baseou-se num modelo de implante dentário que ressignificou o método terapêutico de reabilitação, já que a sua terapia se embasava em apenas duas etapas, sendo a primeira constituída por uma fase cirúrgica e a segunda, que seria após três ou seis meses da primeira, a instalação do componente dentário/protético (Assis et al., 2019).

Devido ao elevado tempo de espera entre as duas etapas, e com isso a existência de reclamações por parte dos pacientes, os pesquisadores da área se dispuseram a buscar as possibilidades de encurtar ao máximo o tempo entre as etapas (Assis et al., 2019). “Com o passar do tempo e o avanço das técnicas cirúrgicas, estudos comprovaram que não há uma diferença significativa entre fazer implantes imediatos em duas etapas ou apenas em uma” (Monezi et al., 2019, p. 2).

A técnica de implante imediato é sucesso na implantodontia, haja visto que ela reduz o número de cirurgias para apenas uma, no qual é realizada no mesmo dia da colocação do implante o componente protético. Todavia, para que o sucesso do procedimento seja alcançado é pontuado que o mesmo deve ser aplicado em pacientes categorizados no grupo de indicações, donde fatores como, qualidade óssea, padrão da oclusão, hábitos parafuncionais e boas condições sistêmicas do paciente, são levados em conta para execução desta metodologia de reabilitação oral (Martins et al., 2020a).

Ademais, um dos grandes desafios, para esta técnica, é a manutenção da estrutura periodontal e do osso de suporte. As técnicas pouco invasivas para exodontia e continuidade da integridade do tecido periodontal, com a inserção imediata de implantes, seguida de provisionalização imediata, têm se mostrado como uma excelente alternativa na preservação da arquitetura gengival (Bezerra, 2022).

A literatura tem mostrado que fazer uso da técnica é uma escolha promissora para pacientes que buscam a recuperação do sorriso de forma rápida e eficaz, com a conquista do objetivo em apenas um dia, não necessitando de retorno ao consultório odontológico por n vezes (Chaud et al., 2023). Assim sendo, o uso da técnica vem principalmente para aqueles que desejam simplificar o procedimento com uma redução do tempo de tratamento em prol da recuperação funcional, estética e consequentemente, emocional (Assis et al., 2019).

Diante disso, o problema dessa pesquisa consiste em entender: como o implante imediato é determinado como um modelo de terapia benevolente aos pacientes que buscam a recuperação imediata do sorriso? É imperioso ressaltar que, ainda que esse trabalho seja um conjunto de estudos realizados por outros autores e pesquisadores, a presente pesquisa não se trata de uma mera repetição do que já foi dito ou escrito por tais doutrinadores, mas sim a configuração de uma releitura resultante de pesquisas, estudos, análises e observações que pressupõem uma contribuição ao menos diferenciada.

Para o entendimento desse problema, este trabalho teve como objetivo geral estudar a técnica do implante imediato na região anterior de maxila, que preconizam sua utilização na reabilitação de dentes perdidos. Do mesmo modo a pesquisa teve como objetivos específicos: analisar bibliografias existentes sobre implantes imediato, discutir seu protocolo e suas indicações, bem como discorrer sobre fatores implicados no sucesso e prognóstico da técnica.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OSSEOINTEGRAÇÃO

Num processo natural, após a ausência do dente, acontece a “reabsorção óssea alveolar progressiva, cumulativa e crônica, provocada pela falta de estímulo do ligamento periodontal” (Ribeiro, 2021, p. 12). A ausência do dente resulta em alterações morfológicas em áreas como o canal mandibular, forame mentoniano e seio maxilar, onde esta ação torna-os superficializados (devido a atrofia óssea das arcadas), o que limitava a indicação da colocação de implante, até mesmo os curtos (Carvalho, 2021).

Determina-se que o desenvolvimento alveolar se encontra diretamente condicionado à erupção dentária, sendo assim, na ausência do dente, o rebordo alveolar encontrar-se-á reduzido em tamanho. Essa situação é observada principalmente em casos de exodontias múltiplas seguidas de reabilitação condicionada a próteses mucossuportadas (Cavalcante et al., 2021).

A recuperação de pacientes que sofreram com a perda de um elemento dentário é desafiante para os implantodontistas, já que situações com “alto nível de reabsorção, a baixa qualidade óssea e presença dos seios maxilares pneumatizados, são obstáculos no planejamento dos implantes osseointegrados”, que são uma realidade eficiente da atualidade (Ribeiro, 2021, p. 12).

Os implantes osseointegrados, como ação terapêutica, promulgam a recuperação funcional e estética perdida, pois são restabelecidas a mastigação e a fonação e a autoestima. Além disto, o uso de implantes osseointegrados, solucionar a instabilidade no caso de pacientes que fazem o uso de próteses mucossuportadas, que em determinados casos, nota-se a falta de contenção delas (Skalak, 1983; Ribeiro, 2021).

Debates acerca de osseointegração em implantodontia acontecem desde quando o professor Branemark iniciou os estudos que tratam sobre implantes osseointegrados para tratar perdas dentárias (Coelho, 2019).

A osseointegração é um termo definido como a ancoragem de um implante num tecido ósseo. Por intermédio de uma técnica cirúrgica, o contato passa a existir de maneira ininterrupta/direta entre o osso vivo e o implante, acoplando-o e fixando-o permanentemente (Branemark et al., 1969).

Adell et al. (1981) pontuam que compreender sobre osseointegração é basilar quando a temática discutida fica estabelecida em implantação imediata. Isto porque esse processo biológico equipara-se ao processo cicatricial quando a perspectiva é evidenciada na remodelação e maturação dos tecidos lesionados. Na osseointegração, existe a particularidade da necessidade de fixação do implante ao tecido ósseo, livre de osteonecrose. A osseointegração é o fato primordial para que haja sucesso na ancoragem do implante, tal qual garantirá um resultado satisfatório tanto para o paciente como para o profissional implantodontista.

O processo de osseointegração tem início a partir do contato sanguíneo com a superfície do implante e a formação de um coágulo nos espaços livres entre a linha de perfuração e o material. O fibrinogênio presente no sangue se deposita sobre o titânio, permitindo o contato das plaquetas à superfície, cuja degranulação libera elementos de crescimento e atraem células indiferenciadas. Durante a formação do coágulo, é formada uma rede tridimensional de fibrina. As células osteogênicas reconhecem a superfície do implante como estável e progridem a diferenciação em osteoblastos, células que secretam uma matriz proteica não colagênica, composta por osteopontina e sialoproteína, que passam por mineralização. A aposição óssea produz um osso trançado, que pode ser reconhecido pelo padrão desorganizado das fibras de colágeno mineralizadas. Posteriormente, os osteoblastos são incluídos na matriz óssea e se diferenciam em osteócitos. Após as etapas de maturação óssea do osso haversiano, em organização circular concêntrica de fibras de colágeno, as propriedades mecânicas aumentam (Dentz et al, 2018, p. 30).

A técnica proposta por Branemark ressignificou a odontologia moderna sobre implantes (Ribeiro, 2021), e com o avançar da utilização da técnica, por intermédio de novos estudos clínicos, observou-se que não fazia diferença entre fazer implantes em uma ou duas etapas, o que possibilitou a inserção do protocolo de carga imediata na implantodontia, ou seja, as próteses dentárias são fixadas no parafuso numa única seção (Monezi et al., 2019).

Sucesso desde as primeiras vezes em que a técnica foi utilizada, já que essa proporcionava excelentes benefícios quando comparada às técnicas anteriores de reabilitação oral (as que exigiam duas etapas), a osseointegração obteve altas taxas de sucesso, atingindo quase que 90% de eficácia dentre todos que foram submetidos ao protocolo. Os 10% restantes ficavam correlacionados a fatores de risco que impediam a conexão/ancoragem/fixação entre o implante e o osso, no qual é possível citar sobre condições locais (tabagismo, falha cirúrgica e medicamentos à base de bisfosfonatos) e/ou sistêmicas (diabetes *mellitus*, doença periodontal e osteoporose) que ocasionaram no insucesso (Oliveira et al., 2023).

2.2 IMPLANTE IMEDIATO

A região anterior da maxila representa uma das áreas de maior exigência estética na reabilitação oral. A perda dentária nessa zona compromete não apenas a função mastigatória, mas também a aparência facial, a harmonia do sorriso e, consequentemente, a autoestima do paciente. Nesse contexto, o implante imediato surge como uma alternativa promissora, pois possibilita a instalação do implante no mesmo momento da extração dentária, reduzindo o tempo total de tratamento e promovendo uma reabilitação mais ágil e esteticamente satisfatória (Naciff; Pinheiro, 2020).

Estudos asseguram que pacientes que recebem implantes imediatos apresentam uma evolução significativa na satisfação pessoal e na funcionalidade oral, visto que a colocação do dente artificial no mesmo dia da extração proporciona não apenas uma solução estética, mas também funcional, impactando positivamente na autoconfiança e no bem-estar emocional. Isso é particularmente relevante na região anterior da maxila, onde qualquer ausência dentária é facilmente perceptível e socialmente constrangedora (Ferreira Neto et al., 2024).

Além da estética, o implante imediato favorece a preservação dos tecidos moles e da arquitetura óssea alveolar, fatores essenciais para o sucesso do resultado final. A preservação da tábua óssea vestibular, por exemplo, contribui para o contorno natural da gengiva e para a manutenção da papila interdental, elementos-chave para alcançar uma reabilitação com aparência natural. Quando bem indicado e executado,

o procedimento oferece alta previsibilidade estética, especialmente quando associado à carga imediata e ao uso de provisórios anatomicamente adequados (Andreiuolo et al., 2016).

A técnica do implante imediato foi vista/utilizada e consequentemente relatada em 1978 na Alemanha após o professor Wilfried Schulte da Universidade de Tübingen que efetuou o protocolo através de uma prótese de cerâmica implantada logo após a colocação do parafuso. Já em 1990, sob a supervisão de ensaios laboratoriais o protocolo sofreu adequações, no qual foi inserida a técnica da cirurgia guiada, que buscavam melhorias no processo cicatricial ósseo em prol de se corrigir possíveis alterações ósseas dos implantes dentários. Desde então a técnica passou a ser difundida e amplamente utilizada, pois tinha como vantagem principal a entrega do resultado imediato devido a ter um menor tempo de tratamento (Buser et al., 2017).

Este protocolo cirúrgico, que visa as reabilitações orais, é defendido por muitos autores devido ao procedimento “minimizar a reabsorção óssea e assim por consequência conservar a arquitetura gengival, proporcionando próteses mais adequadas” (Mota, 2018, p. 7).

A prótese imediatamente inserida sobre o implante é um protocolo altamente previsível tanto por parte do paciente, quanto pelo cirurgião-dentista. Assim, define-se por implante imediato aquele em que a prótese unitária ou múltipla é inserida utilizando o próprio alvéolo dental (Ferreira Neto et al., 2024).

A implantodontia no início focava na obtenção da fixação do implante no osso alveolar restante, sem considerar muito a posição da futura prótese. Com o passar do tempo, os profissionais aprenderam que colocar implantes em rebordos alveolares reabsorvidos poderia resultar em próteses pouco estéticas (Mecall; Rosenfeld, 1991).

Levando em conta a localização do implante, uma ancoragem na parede palatina do alvéolo, com o objetivo de garantir estabilidade inicial e criando espaço entre o implante e o osso vestibular é comumente recomendada para resultados mais satisfatórios. Quando a lacuna vestibular entre o corpo do implante e a parede óssea restante é enxertada com biomaterial, esse enxerto no gap entre implante e tecido osseo, tende a manter o volume osso vestibular após a exodontia (Osman et al., 2015).

Outro ponto importante a se considerar é a necessidade de garantir uma estabilidade inicial satisfatória, para que seja possível confeccionar coroas provisórias

com design apropriado, buscando o perfil de emergência, mantendo-as até que o osso e a gengiva estejam completamente maduros e estabilizados (Araújo et al., 2006).

Diversas pesquisas científicas demonstraram que não existe diferença significativa na sobrevivência em longo prazo de implantes dentários restaurados com coroas provisórias logo após a cirurgia ou após um período de espera. Além disso, em relação à taxa de sucesso, ambos os procedimentos de restauração parecem apresentar resultados bastante similares no que diz respeito ao tecido mole circundante. Logo, diversos estudos realizados com implantes dentários colocados imediatamente após a extração sugerem que a formação da papila interdental é mais completa em restaurações tardias do que nas restaurações realizadas logo após a cirurgia (Slagter et al., 2014).

Porém, se o paciente apresentasse atrofia do seio maxilar acrescida de sua pneumatização, a realização do processo de implantodontia só seria efetivada ante a realização de enxerto ósseo e levantamento de seio maxilar (Branemark, 1983). Do contrário, o procedimento denotaria em falha no processo de instalação dos implantes osseointegrados, que se daria em razão de a estabilidade e a ancoragem dos implantes estarem comprometidas (Gaviria et al., 2014).

Para simplificar as orientações sobre a colocação rápida de implantes em uma lista de verificação concisa e fácil de seguir pelo cirurgião-dentista, pode-se recomendar que a escolha por essa técnica seja feita ao se deparar com as seguintes situações clínicas: parede óssea vestibular íntegra; inexistência de recessão dos tecidos moles imediatamente após a extração dentária; quantidade suficiente de osso entre os dentes adjacentes; existência de osso além da ponta do dente para garantir uma boa fixação do implante (Angelis et al., 2021).

Diversos elementos influenciam no êxito estético de um implante imediato, sendo que o ponto fundamental é sem dúvida o posicionamento correto do implante. Uma vez que o alvéolo esteja adequado para essa finalidade, a colocação do implante deve ser feita com o mesmo zelo aplicado na extração dentária sem traumas previamente discutida. Um protocolo rígido e padronizado deve ser seguido, levando em consideração as características anatômicas específicas de um alvéolo após a extração, especialmente em regiões estéticas (Horowitz et al., 2012).

A região de inserção do implante necessita de uma preparação adequada, com as brocas sendo posicionadas de forma a seguir a parede óssea palatina como referência e utilizando o osso apical até a altura permitida pelo osso residual. É importante ressaltar que o osso residual apical é fundamental para garantir a estabilidade e ancoragem necessárias ao implante (Zaki et al., 2021). Portanto, a escolha do comprimento do implante deve ser feita com precisão durante o planejamento. Após a preparação da região de inserção do implante, é essencial utilizar uma sonda periodontal para verificar a integridade das paredes. Por fim, o implante deve ser inserido com a plataforma ao nível ou abaixo da margem da parede óssea vestibular (Zucchelli et al., 2018).

A execução da osteotomia direcionada para o palato é determinada pela estrutura do alvéolo após a extração. A parede externa do alvéolo geralmente apresenta espessura reduzida e, em regiões estéticas, costuma ter menos de 1 mm de espessura. Embora pesquisas iniciais tenham sugerido que a inserção imediata do implante poderia manter a altura original do rebordo alveolar, estudos mais recentes em seres humanos e animais demonstraram que essa estrutura não mantém sua forma por mais de 3 a 4 meses após a instalação do implante (Araújo et al., 2019). Por isso, é crucial manter um posicionamento voltado para o palato, uma vez que a reabsorção inevitável da parede externa fina pode comprometer a eficácia e a durabilidade do implante a longo prazo se ele for colocado próximo à região externa do alvéolo (Araújo-Pires et al., 2016).

2.3 DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO: AVERIGUAÇÃO DE PRÉ-REQUISITOS PARA QUE HAJA A POSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE IMPLANTES IMEDIATOS

Como em toda e qualquer ação diária, o planejamento é basilar. Na implantodontia, a se tratar, especialmente do implante imediato, é necessário evidenciar que o bom planejamento é um dos passos cruciais para a obtenção de sucesso no caso (Martins; Pedraça; Ferreira Filho, 2020).

Anteriormente a intervenção terapêutica, o protocolo de reabilitação bucal com implantes deve ser conduzido por meio de um recurso denominado como planejamento reverso, ao qual possibilita que implantodontista e paciente cheguem

num consenso em escolha da melhor via de opção da terapia, acrescida de uma elaboração das etapas do procedimento cirúrgico, que é confeccionada em softwares que possibilitam a visualização tridimensional do resultado do tratamento. Além disso, essa possibilidade tecnológica favorece quanto aos aspectos de riscos de complicações trans-operatórias provedoras de insucesso, que por intermédio da implantodontia assistida por computador (CAI), serão minimizadas suas chances de acontecimento (Spielau; Hauschild; Katsoulis, 2019).

Ademais, evidencia-se que o diagnóstico e o planejamento dos implantes imediatos, são precedidos de uma criteriosa avaliação por parte do profissional, e por isso requerem uma atenção especial quanto aos seguintes fatores: histórico médico, (evidenciando inclusive a respeito de patologias sistêmicas, e odontológico do paciente ao qual deve incluir a solicitação de exame clínico bucal, fotos clínicas, modelos de estudo, radiografias e tomografia computadorizada das áreas de interesse, ou seja, naquelas em que serão inseridos os implantes (Becker; Goldstein, 2008).

É preciso determinar que durante o exame clínico, é essencial que o implantodontista observe possíveis alterações na mucosa, a espessura dos tecidos moles e realize a palpação do local de inserção dos implantes, garantindo assim um diagnóstico preciso para um planejamento adequado (Lindhe, 2008). Além disso, a criação de um guia cirúrgico na fase final do planejamento é fundamental para garantir a previsibilidade no posicionamento dos implantes (Martins; Pedraça; Ferreira Filho, 2020).

Destaca-se ainda que nesta fase de diagnóstico e planejamento cabe ao implantodontista determinar se o paciente encontra-se ou não apto para ser submetido ao protocolo, pois, existem casos em que se é contraindicado um implante dentário imediato (Monezi et al, 2019). E sobre as indicações e contraindicações o Quadro 1 faz menção.

Quadro 1 - Indicações e contraindicações quanto ao uso de implantes imediatos

Indicações	Contraindicações
Pacientes com boa saúde sistêmica e periodontal	Presença de infecção ativa ou exsudato purulento no local da extração
Dentes com fraturas radiculares, reabsorções ou falhas endodônticas com preservação óssea adequada	Volume ósseo apical ou vestibular insuficiente para garantir estabilidade primária do implante
Presença de osso residual suficiente (principalmente na região apical) para estabilidade inicial	Presença de defeitos ósseos extensos ou deiscência/fenestração óssea na tábua vestibular
Gengiva espessa e tecido mole favorável à cicatrização e estética	Biotipo gengival fino ou recessão gengival acentuada
Extrações sem trauma, com preservação das paredes ósseas alveolares	Condições anatômicas de risco, como proximidade extrema do seio maxilar ou do canal mandibular
Pacientes com expectativas estéticas elevadas e necessidade de redução no tempo de tratamento	Pacientes com controle sistêmico inadequado (diabetes não controlado, osteoporose severa, imunossupressão)

Fonte: Monezi et al. (2019); Amaro; Conforte (2022) - Adaptado

Além disso, é preciso afirmar que o sucesso da colocação imediata do implante está intimamente ligado à correta execução da remoção do dente (exodontia), visando evitar a perda de estrutura óssea. Para isso, é fundamental realizar uma curetagem minuciosa, eliminando qualquer lesão ou resquício do ligamento periodontal. Dessa forma, é importante seguir critérios como: preservação da papila interdental, uso de um elevador delicado para manter a integridade óssea, aplicação de força controlada e odontosecção quando necessário, curetagem meticulosa para remover agentes patogênicos, formação do coágulo para iniciar a cicatrização óssea e preenchimento adequado. Após a extração, as paredes do osso alveolar devem ser alisadas para permitir a regeneração celular, utilizando curetas para localizar as tábuas vestibular e palatina, onde serão inseridos o guia cirúrgico e a broca. Assim, determina-se que o sucesso da colocação do implante está diretamente relacionado aos procedimentos cirúrgicos adotados, tanto na exodontia quanto na instalação do implante e prótese dentária (Becker, 2005; Monezi et al., 2019).

3 CONCLUSÃO

Com base na análise teórica desenvolvida, conclui-se que o implante imediato representa uma alternativa moderna, eficiente e esteticamente vantajosa para a reabilitação oral, especialmente na região anterior da maxila. A técnica permite redução no tempo total de tratamento, melhora na preservação dos tecidos moles e duros e proporciona impactos positivos na autoestima dos pacientes. No entanto, seu sucesso depende de critérios clínicos bem definidos, da habilidade do profissional e de um planejamento rigoroso, que envolva avaliação anatômica, condições ósseas, saúde sistêmica e protocolo cirúrgico adequado. O conhecimento técnico-científico e a constante atualização do cirurgião-dentista são fundamentais para garantir previsibilidade, longevidade e resultados satisfatórios tanto do ponto de vista funcional quanto estético.

REFERÊNCIAS

ADELL, R; et al. A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. **Int J Oral Surg**, v. 10, n. 6, p. 387-416, dez., 1981.

AMARO, LCF; CONFORTE, JJ. Implante imediato em alvéolo fresco. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 5, p. 1209-1230, 2022.

ANDREIUOLO, R; VASCONCELLOS, F; ANDRADE, A; GROISMAN, M; VIDIGAL JÚNIOR, GM. Implante imediato na região anterior: aspectos cirúrgicos e protéticos. **Rev. bras. odontol.**, Rio de Janeiro, v. 73, n. 1, p. 84-88, 2016

ANGELIS N.; SIGNORE A.; ALSAYEDA.; HOCKW. H.; SOLIMEI L.; BARBERISF.; AMAROLI A. Immediate Implants in the Aesthetic Zone: Is Socket Shield Technique a Predictable Treatment Option? A Narrative Review., **J Clin Med.**, v. 10, n. 21, p. 4963-4978, 2021.

ARAÚJO, M. G.; SILVA, C. O.; SOUZA, A. B.; SUKEKAVA, F. Socket healing with and without immediate implant placement. **Periodontol 2000.**, v. 79, n. 1, p. 168-177, 2019.

ARAÚJO, M. G.; SUKEKAVA, F.; WENNSTRÖM, J. L.; LINDHE, J. Tissue modeling following implant placement in fresh extraction sockets. **Clin Oral Implants Res.**, v. 17, n. 6, p. 615-624, 2006.

ARAÚJO-PIRES A.C., MENDES V.C., FERREIRA-JUNIOR O., CARVALHO P.S., GUAN L., DAVIES J.E. Investigation of a novel PLGA/CaP scaffold in the healing of tooth extraction sockets to alveolar bone preservation in humans. **Clin Implant Dent Relat Res.**, v. 1, n. 18, p. 559-70, 2016.

ASSIS, LC; et al. Uso de carga imediata em implantodontia: revisão dos conceitos atuais. **RvACBO**, v. 8, n. 3, p. 82-87, 2019.

BECKER, W; GOLDSTEIN, M. Immediate implant placement: treatment planning and surgical steps for successful outcome. **Periodontol** 2000, v. 47, p. 79-89, 2008.

BEZERRA, LS. **Instalação de implante imediato após exodontia do elemento 21:** relato de caso clínico. 2022. 16p. Trabalho de Conclusão de Curso (bacharel em Odontologia), Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Odontologia, Uberlândia, 2022.

BRANEMARK, P. I. Osseintegration and its experimental background. **J Prosthet Dent.**, v. 50, n. 3, p. 399-410, 1983.

BUSER, D; CHAPPUIS, V; BELSER, CS; CHEN, S. Implant placement post extraction in esthetic single tooth sites: when immediate, when early, when late?. **Periodontology** 2000., v. 73, n. 1, p. 84- 102, jan., 2017.

CARVALHO, CCM. **All-on-four:** revisão da literatura. Disponível em: <https://faculadefacsete.edu.br/monografia/files/original/e20cb17599d808b92cbbd42c1619a641.pdf>. Acesso em 26 jan. 2024.

CAVALCANTE, R. A.; BATISTA, T. R. M., DANTAS, A. M. X.; DIAS, C. R. B.; SOUZA JUNIOR, G. R.; DANTAS, R. M. X. Reabilitação implantossuportada pela técnica “All on four” após periimplantite mandibular: relato de caso. **Odontol. Clín.-Cient.**, Recife, v. 20, n. 1, p. 74-78, mar., 2021.

CHAUD, GB; et al. Prótese sobre implante –carga imediata: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 6, n. 4, p.16236-16248, jul./ago.,2023.

COELHO, IP. **Técnica protocolo All-on-four.** Disponível em: <http://www.famed.edu.br/wp-content/uploads/2014/11/Tecnica-Protocolo-All-On-Four-Esp-Isaac-Pereira-Coelho.pdf>. Acesso em 13 mai. 2025.

DENTZ, DCV; BARCELLOS, MS; ANZILIERO, AH; CORREA, J; MARCHIORI, PM; TAKEMOTO, MM. Osseointegração em implantes. **Revista Tecnológica**, v. 2, n. 2, p. 28-37, jul./dez., 2018.

FERREIRA NETO, MDA; AYRES, AS; SOUZA, ABC; CARNEIRO, EA; FERREIRA, LG. Implante imediato em região anterior da maxila. **REAC**, v. 47, n. 1, p. 1-8, 2024.

GAVIRIA, L.; SALCIDO, J. P.; GUDA, T.; ONG, J. L. Current trends in dental implants. **J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg.**, v. 40, n. 2, p. 50-60, 2014.

HOROWITZ, R.; HOLTZCLAW, D.; ROSEN, P. S. A review on alveolar ridge preservation following tooth extraction. **J Evid Based Dent Pract.**, v. 12, n. 3, p. 149-160, 2012.

LINDHE, J. **Tratado de periodontia clínica e implantologia oral**. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2005.

MAGRO, AK; CALZ, SC; LAUXEN, J; SANTOS, R; VALCANAIA, TC; MAGRO, ED. Tratamento do sorriso gengival com toxina botulínica tipo A: relato de caso. **RFO**, Passo Fundo, v. 20, n. 1, p. 81-87, jan./abr., 2015.

MARTINS, IM; PEDRAÇA, VKM; FERREIRA FILHO, MJS. Reabilitação oral com implante imediato: revisão de literatura. **Braz. J. of Develop.**, Curitiba, v. 6, n. 12, p. 95785-95794, dez., 2020.

MARTINS, SHL; VIEIRA, GHA; BEZERRA, FJB; GHIRALDINI, B; SOUZA, SLS. Implante imediato pós-exodontia em região de molar utilizando um novo implante com a técnica de preparo intrarradicular e preservação alveolar. **J Multidiscipl Dent**, v. 10, n. 2, p. 160-167, mai./ago., 2020a.

MIGUEL JUNIOR, H; GENOVESE, WJ; BELTRÃO, CFB.; KASSARDJIAN, F; CERRI, A. Implante imediato associado ao enxerto de tecido conjuntivo: relato de caso clínico. **Rev Assoc Paul Cir Dent.**, São Paulo, v. 70, n. 3, p. 312-6, abr., 2016.

MONEZI, LLL; MATOS, EMC; CORRÊA, RCM; CAVALCANTE, TC. Implantes imediatos: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde / Electronic Journal Collection Health**, v. 30, p. 1-6, jun./ago., 2019.

NACIFF, NN; PINHEIRO, DA. **Implante com carga imediata em região anterior de maxila:** revisão de literatura. 2020. Disponível em: <https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/NAZRA%20NACIFF.pdf>. Acesso em 01 jul. 2025.

OLIVEIRA, LCM; ARAÚJO, RV; NORTE, AL; SÁ, JL. Fatores sistêmicos e locais que causam insucesso na osseointegração de implantes dentários. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 2, p. 70-85, mar./abr., 2023.

OSMAN R.B., SWAIN M.V. A critical review of dental implant materials with na emphasis on titanium versus Zirconia. *Materials.*, n. 8, p. 932-58, 2015.

RIBEIRO, TLL. **Técnica “All-on-four” na recuperação de maxilas totalmente edêntulas e atróficas:** Revisão de literatura. Monografia (Especialização) - Faculdade Sete Lagoas, curso de especialização em implantodontia. Rio Claro - Brasil, 2021.

SCHROPP L, et al. Bone healing and soft tissue contour changes following single tooth extraction: a clinical and radiographic 12-month prospective study. **International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry**, v. 23, n. 4, p. 313-323, 2003.

SKALAK, R. Biomechanical considerations in osseointegrated prostheses. **J Prosthet Dent.**, v. 49, n. 6, p. 843-848, 1983.

SLAGTER, KW; HARTOG, L; BAKKER, NA; VISSINK A; MEIJER, HJA; RAGHOEBAR, GM. Immediate Placement of Dental Implants in the Esthetic Zone: A Systematic Review and Pooled Analysis., **J Periodontol.**, v. 85, n. 7, p. 241-250, 2014.

SOUZA, ACJ; FARIA, NLC; RODRIGUES, MR. **Implante imediato em região estética:** uma revisão de literatura. 2021. Disponível em: https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ5MfV8aGFAxUDqpUCHWEPAAEQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Frepositorio.alfaunipac.com.br%2Fpublicacoes%2F2023%2F931_implante_imediato_em_regiao_estetica_uma_revisao_de_literatura.pdf&usg=AOvVaw1M73ZxNq-ik2oep-FARcNk&opi=89978449. Acesso em 13 mai. 2025.

SPIELAU, T; HAUSCHILD, U; KATSOULIS, J. Computer-assisted, template-guided immediate implant placement and loading in the mandible: a case report. **BMC Oral Health.**, v. 19, n. 55, p. 1-9, abr., 2019.

ZAKI, J.; YUSUF, N.; EL-KHADEM, A.; SCHOLTEN, R. J. P. M.; JENNISKENS, K. Efficacy of bone-substitute materials use in immediate dental implant placement: A systematic review and meta-analysis. **Clin Implant Dent Relat Res.**, v. 23, n. 4, p. 506-519, 2021.

ZUCHELLI G; SHARMA P; MOUNSSIF. Esthetics in periodontics and implantology. **Periodontol 2000**, v. 77, n. 1, p. 7-18, 2018.